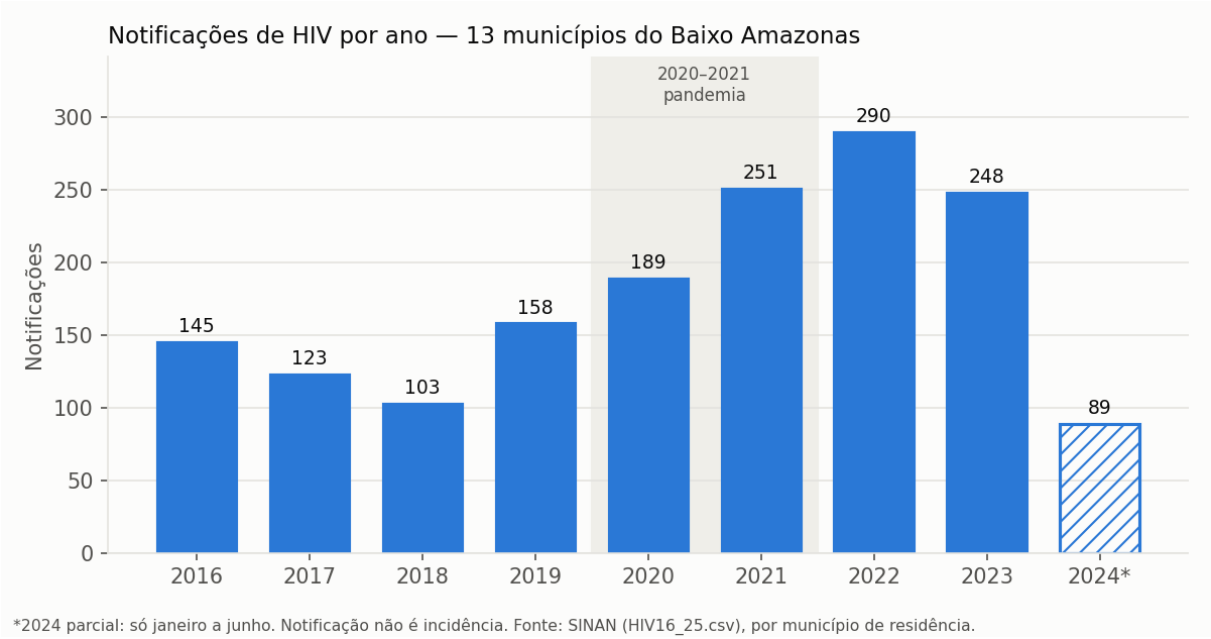
HIV no Baixo Amazonas: o que os dados mostram

Resumo da interpretação dos principais achados · Notificações do SINAN (Ministério da Saúde) de residentes em 13 municípios · dados até 30/06/2024 · elaborado em 05/11/2026

Antes de ler: os números são de **notificações**, isto é, pessoas diagnosticadas e registradas no sistema. Não são o total de pessoas com HIV nem de novas infecções (notificação não é incidência). Há subnotificação, e os números dependem da testagem e do registro em cada município. Não há população na base, por isso não há taxas: os municípios são comparados só em números absolutos e em participação percentual. 2024 tem só 6 meses de dados e 2025 não está na base.

Em uma frase

Entre 2016 e 2023, as notificações de HIV na região cresceram (de 145 para 290 em 2022), concentram-se em Santarém e em homens jovens, e o aumento pode refletir tanto mais transmissão quanto mais testagem e registro — os dados não permitem separar uma coisa da outra.



Notificações por ano. 2024 hachurado: só janeiro a junho. Faixa cinza: 2020–2021.

1. As notificações cresceram, sobretudo durante e depois da pandemia

O menor ano foi 2018 (103) e o maior foi 2022 (290). Em 2020, enquanto as notificações no Brasil caíram 21,8% (51.053 para 39.946), na região subiram 19,6% e, em 2021, mais 32,8%. O aumento veio quase todo de Santarém (112, 140 e 201 em 2019, 2020 e 2021); os demais municípios somados ficaram estáveis (46, 49, 50) e subiram em 2022 (91).

O que isso significa: A região não seguiu a queda nacional da pandemia. Isso pode indicar ampliação da testagem ou mudança no registro em Santarém, ou ainda diagnósticos que estavam represados e apareceram depois.

Cuidado: Não é possível afirmar a causa. 2024 parece menor (89 no 1º semestre, contra 147 no 1º semestre de 2023), mas pode ser atraso de digitação.

Pergunta para a vigilância: O que mudou na oferta de testagem e na rotina de notificação de Santarém entre 2019 e 2021?

2. Santarém concentra as notificações, e muitos moradores de outros municípios são notificados lá

Santarém tem 1.083 das 1.596 notificações (67,9%) de 2016 a 2024. 312 notificações (19,5%) foram feitas fora do município de residência, 281 delas em Santarém. Os municípios com maior proporção de moradores notificados em Santarém foram Curuá (18 de 18, 100,0%), Mojuí dos Campos (26 de 26, 100,0%), Belterra (19 de 22, 86,4%); entre os maiores, Óbidos (53,5%) e Juruti (63,5%).

O que isso significa: Santarém funciona como polo de diagnóstico da região. Contar pelo município de residência evita inflar o polo e esconder os demais.

Cuidado: Concentração em números absolutos não é risco maior: sem população, não há taxa. Terra Santa, Faro, Curuá, Almeirim, Belterra, Prainha, Mojuí dos Campos têm menos de 30 notificações no período, e qualquer percentual nesses municípios é instável.

Pergunta para a vigilância: Os municípios que mandam pacientes para o polo têm testagem e acompanhamento locais suficientes?

3. Predominam homens e jovens; cresce a exposição homossexual entre homens

De 2016 a 2023, homens são 72,2% das notificações; a participação das mulheres caiu de 33,3% (2016–2019) para 24,8% (2020–2023). Metade das pessoas (49,7%) tem de 15 a 29 anos. Entre homens, a categoria homossexual passou de 32,6% para 47,9% e a bissexual caiu de 19,8% para 9,4%. Na região como um todo, a heterossexual segue a maior (53,5%).

O que isso significa: O HIV notificado na região é, sobretudo, de homens jovens, e as ações de prevenção e testagem precisam chegar a eles, incluindo homens que fazem sexo com homens.

Cuidado: As diferenças entre períodos são estatisticamente significativas (teste de proporções; para mulheres, $p < 0,001$), mas mostram mudança nas notificações, não necessariamente na epidemia. A exposição é autodeclarada e pode refletir mudança na forma de perguntar.

Pergunta para a vigilância: A testagem de homens jovens aumentou? E as mulheres fora do pré-natal estão sendo testadas?

4. Gestantes notificadas tarde na gravidez

96 de 419 mulheres (22,9%) estavam gestantes na notificação. Dessas, 70 (72,9%) estavam no 2º ou 3º trimestre e só 20 no 1º. Houve 21 notificações com transmissão de mãe para filho no período.

O que isso significa: Diagnóstico tardio na gestação reduz o tempo para evitar a transmissão para o bebê. É o ponto em que a vigilância pode agir mais diretamente.

Cuidado: O trimestre é o da notificação, não o do diagnóstico; gestantes têm ficha própria no SINAN, que não está nesta base.

Pergunta para a vigilância: O teste de HIV está sendo feito no 1º trimestre do pré-natal em todos os municípios?

5. O registro melhorou, mas o desfecho dos casos não é acompanhado

A escolaridade ignorada caiu de 10,6% para 2,6%. Por outro lado, 98,1% dos casos constam como "vivo" e só 18 óbitos foram registrados de 2016 a 2023.

O que isso significa: Os campos da ficha estão mais completos, mas a evolução não é atualizada; o painel não serve para medir mortalidade por aids.

Cuidado: Mudanças bruscas no perfil (como na escolaridade, a partir de 2020) podem ser efeito do preenchimento.

Pergunta para a vigilância: Os óbitos de residentes estão sendo cruzados com o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)?

O que estes dados não permitem dizer

Pergunta	Por que não
Qual município tem maior risco?	Não há população para calcular taxas.
A epidemia cresceu?	Só há notificações, que dependem da testagem.
Quantas pessoas morreram de aids?	A evolução não é atualizada (exige o SIM).
2024 foi melhor que 2023?	O ano está incompleto e pode receber registros atrasados.
A pandemia causou o aumento?	Os dados mostram coincidência no tempo, não causa.

Próximos passos sugeridos

(1) Incluir a população do IBGE para calcular taxas por município; (2) cruzar com o SIM para óbitos; (3) atualizar a base com os dados completos de 2024 e de 2025; (4) discutir com os municípios as perguntas acima.

Fonte: SINAN/Ministério da Saúde (arquivo HIV16_25.csv). Números calculados a partir de dados/dados_dashboard.json (contagens agregadas, conferidas em resultados/auditoria.md) e resultados/series_indice_2019.csv. Detalhes em resultados/achados_hiv.md e resultados/series_relatorio.md. Documento de uso interno da vigilância epidemiológica.